

CER-AI TEK SAYFALIK SONUÇ RAPORU

Kornea Ektazi Risk Değerlendirme Zekâsı

Nihai cerrahi karar ile buna bağlı tüm sorumluluk ve yükümlülük cerraha aittir. Bu uygulama yalnızca klinik karar destek aracıdır.

ANONYMIZED SAMPLE REPORT / ORNEK RAPOR

Patient and reviewer identification removed.

Genel karar: DURDUR-ERTELE — DURDUR-ERTELE — elektif korneal refraktif cerrahiye devam etmeyin.

OD — DURDUR-ERTELE

Değerlendirme	Hesaplanan sonuç	Sonuç ayrıntısı
İşlem	PRK	
Randleman / ERSS	DİKKAT	Toplam: 3; Sınıflandırma: ASİMETRİK PAPYON
NICE	DİKKAT	Toplam: 8; Sınıflandırma: DİKKAT
Final BAD-D	DİKKAT	Değer: 2.09; Sınıflandırma: ŞÜPHELİ
PS3	DURDUR-ERTELE	Orta / Yüksek: 2 / 0; İşleme özgü karar: Raw PS3 PRK disposition: DEFER. Triggering PS3 finding(s): thinnest: En ince pakimetri 492 µm, 470-499 µm aralığında.; PPI ortalaması: PPI ortalaması 1.37 > 1.20.
Cerrahi güvenlik	UYGUN	PRK rezidüel stroma kalınlığı (µm): 382; PRK PTA (%): 22.358; Tahmini postoperatif Km (D): 43.9; Postoperatif Km modeli: MİYOPIK 0,8 D/D TAHMİNİ; En yüksek hipermetropik tedavi bileşeni (D): -3.5
Seçilen işlem planı	OD — STOP-DEFER — PRK	OZ 6.5 mm — TZ 9 mm — Ablation 60 µm
Mitomisin-C önerisi	ZORUNLU	
Kararın gerekçesi	DURDUR-ERTELE	DURDUR: Raw PS3 PRK disposition: DEFER. Triggering PS3 finding(s): thinnest: En ince pakimetri 492 µm, 470-499 µm aralığında.; PPI ortalaması: PPI ortalaması 1.37 > 1.20.; DİKKAT: ERSS TOPLAM: 3; topography: ASYMMETRIC_BOWTIE (1 puan); signed I-S: 0.67 D; additional scored components: pakimetri: 2 puan; DİKKAT: Final BAD-D: ŞÜPHELİ; DİKKAT: NICE toplamı: 8
Değerlendirme notları / uyarılar		Kornea kalınlık haritası morfolojisi: değerlendirilmedi; cerrah değerlendirmesi gerekir; otomatik PS3 puanlamasına katılmaz. Göreli kalınlık haritası: değerlendirilmedi; cerrah değerlendirmesi gerekir; otomatik PS3 puanlamasına katılmaz. PT/CTSP kalınlık profili morfolojisi: değerlendirilmedi; cerrah değerlendirmesi gerekir; otomatik PS3 puanlamasına katılmaz.

software: 2.0.1 · clinical_policy: CER-AI-2026-10-05-SIGNED-IS-NEGATIVE-BOUNDARY-V13 · source_registry: 2026-09-10-ML7-REUSE-CANONICAL-K · srax_algorithm: FRONT_MAP_SRAX_GT20-2026-09-07 · deployment_sha: f4b2950cb7492664458047cd528684a1a5e2d597

OS — DURDUR-ERTELE

Değerlendirme	Hesaplanan sonuç	Sonuç ayrıntısı
İşlem	PRK	
Randleman / ERSS	DİKKAT	Toplam: 3; Sınıflandırma: ASİMETRİK PAPYON
NICE	DİKKAT	Toplam: 8; Sınıflandırma: DİKKAT
Final BAD-D	DİKKAT	Değer: 1.94; Sınıflandırma: ŞÜPHELİ
PS3	DURDUR-ERTELE	Orta / Yüksek: 2 / 0; İşleme özgü karar: Raw PS3 PRK disposition: DEFER. Triggering PS3 finding(s): thinnest: En ince pakimetri 489 µm, 470-499 µm aralığında.; PPI ortalaması: PPI ortalaması 1.36 > 1.20.
Cerrahi güvenlik	UYGUN	PRK rezidüel stroma kalınlığı (µm): 350.875; PRK PTA (%): 28.246; Tahmini postoperatif Km (D): 42.7; Postoperatif Km modeli: MİYOPIK 0,8 D/D TAHMİNİ; En yüksek hipermetropik tedavi bileşeni (D): -5
Seçilen işlem planı	OS — STOP-DEFER — PRK	OZ 6.5 mm — TZ 9 mm — Ablation 88.125 µm
Mitomisin-C önerisi	ZORUNLU	
Kararın gerekçesi	DURDUR-ERTELE	DURDUR: Raw PS3 PRK disposition: DEFER. Triggering PS3 finding(s): thinnest: En ince pakimetri 489 µm, 470-499 µm aralığında.; PPI ortalaması: PPI ortalaması 1.36 > 1.20.; DİKKAT: ERSS TOPLAM: 3; topography: ASYMMETRIC_BOWTIE (1 puan); signed I-S: 0.81 D; additional scored components: pakimetri: 2 puan; DİKKAT: Final BAD-D: ŞÜPHELİ; DİKKAT: NICE toplamı: 8
Değerlendirme notları / uyarılar		Kornea kalınlık haritası morfolojisi: değerlendirilmedi; cerrah değerlendirmesi gerekir; otomatik PS3 puanlamasına katılmaz. Göreli kalınlık haritası: değerlendirilmedi; cerrah değerlendirmesi gerekir; otomatik PS3 puanlamasına katılmaz. PT/CTSP kalınlık profili morfolojisi: değerlendirilmedi; cerrah değerlendirmesi gerekir; otomatik PS3 puanlamasına katılmaz.

software: 2.0.1 · clinical_policy: CER-AI-2026-10-05-SIGNED-IS-NEGATIVE-BOUNDARY-V13 · source_registry: 2026-09-10-ML7-REUSE-CANONICAL-K · srax_algorithm: FRONT_MAP_SRAX_GT20-2026-09-07 · deployment_sha: f4b2950cb7492664458047cd528684a1a5e2d597

Bu rapor, korneal refraktif cerrahi için CER-AI Preoperatif Ektazi Risk Değerlendirme Protokolü kapsamında oluşturulmuştur. DİKKAT açık cerrah değerlendirmesi gerektirir ancak cerrahiye otomatik olarak ertelemeyiz. DURDUR-ERTELE, belirtilen durdurma/erteleme koşulu giderilmeden cerrahiye devam edilmemesi anlamına gelir. VERİ YETERSİZ / DEĞERLENDİRİLMEDİ sonucu UYGUN kararına izin vermez. Bu klinik karar destek raporu cerrahın bağımsız değerlendirmesinin yerini almaz.